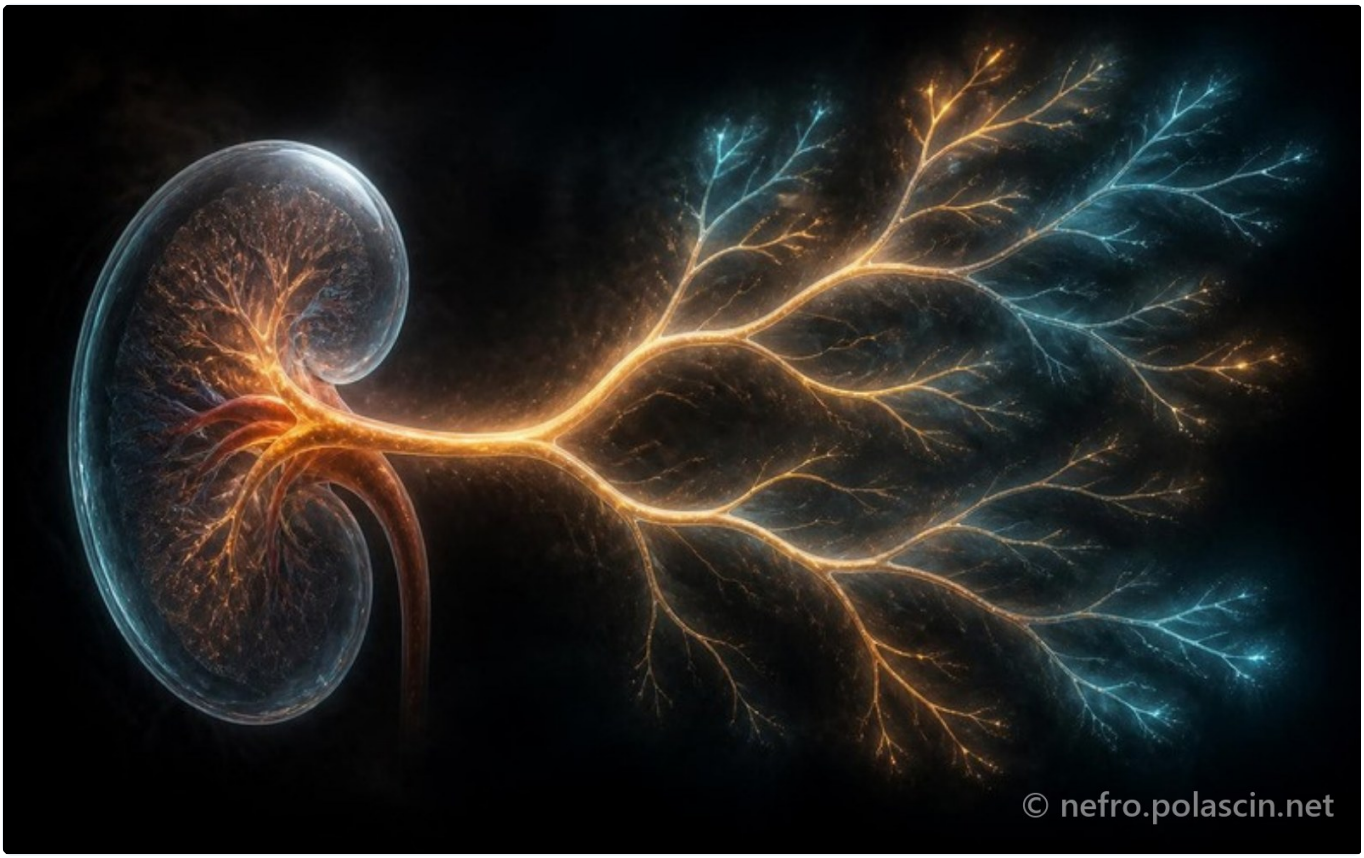
Praktická príloha: Algoritmus manažmentu IgA nefropatie podľa KDIGO 2025 s ohľadom na KDOQI US Commentary

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 19.06.2026



Ilustračná scéna. Algoritmus nenahrádza úsudok, iba ho usporadúva do krokov, ktoré sa dajú zopakovať.

Algoritmus je spracovaný ako stručná praktická príloha na jednu stranu A4. Má pomôcť správne rozpoznať podozrenie na IgA nefropatiu, potvrdiť diagnózu biopsiou, odhadnúť riziko progresie a zvoliť liečbu, ktorá cieli na mechanizmy ochorenia a na spomalenie straty funkcie obličiek.

0) Kedy uvažovať o ďalšom kroku

- ☐ Podozrenie na IgAN: perzistujúca hematuria a/alebo proteinúria u dospelého, po vylúčení bežných alternatívnych príčin.
- ☐ Zásadné pravidlo: diagnózu IgAN potvrdzuje **biopsia obličky**.

1) Kedy poslať pacienta na biopsiu

- ☐ Zvážiť biopsiu, ak dospelý má **proteinúriu ≥ 0,5 g/deň** alebo ekvivalent.
- ☐ Biopsiu nepovažovať za „voliteľnú“, ak výsledok zásadne zmení liečbu a nie sú kontraindikácie.
- ☐ Do dokumentácie uviesť: hematuriu a proteinúriu s kvantifikáciou, vylúčenie významnej alternatívnej príčiny, eGFR a komorbidity relevantné pre riziko biopsie.

2) Po biopsii: ako nastaviť riziko a cieľ liečby

- ☐ Po potvrdení IgAN určiť rizikovosť najmä podľa **eGFR** a **proteinúrie**; histologické parametre využiť podľa Oxfordskej klasifikácie.
- ☐ Cieľ liečby: znížiť proteinúriu čo najskôr a čo najviac, prakticky minimálne **< 0,5 g/deň**, ideálne **< 0,3 g/deň**, ak je to dosiahnuteľné.

- ☐ Súčasne sledovať spomalenie poklesu eGFR, tlak krvi a kardiovaskulárne riziká.

3) Základ pre všetkých

- ☐ Sodík **< 2 g/deň**.
- ☐ Zanechať fajčenie aj vaping.
- ☐ Kontrola hmotnosti a aeróbna aktivita podľa tolerancie.
- ☐ Cieľ tlaku krvi približne **≤ 120/70 mm Hg**, podľa individuálnej tolerancie.
- ☐ Ak je indikovaná a tolerovaná, použiť **blokádu RAS** (ACEi/ARB).
- ☐ Zvážiť **inhibítor SGLT2**, ak je pre pacienta indikovaná a realizovateľná.
- ☐ Po týchto krokoch prehodnotiť proteinúriu podľa trendu, nie podľa jednorazovej hodnoty.

4) Ktorých pacientov liečiť cielenejšie

- ☐ Špecifickú liečbu zvažovať pri vyššom riziku progresie, najmä pri pretrvávajúcej proteinúrii napriek základnej nefroprotekcii.
- ☐ Pri rozhodovaní zohľadniť eGFR, proteinúriu, histológiu, komorbidity a dostupnosť liečby.

5) Voľba špecifickej liečby

A) Ak je dostupný Nefecon

- ☐ Zvážiť **9-mesačný cyklus** u rizikových pacientov podľa KDIGO.
- ☐ Pacientovi vysvetliť, že sa hodnotí najmä dlhodobejší trend eGFR a proteinúrie, nie iba krátkodobá zmena po začiatku liečby.
- ☐ Po vysadení môže pretrvávať len čiastočný „legacy effect“ na proteinúriu.

B) Ak Nefecon nie je dostupný

- ☐ Zvážiť režim so **zníženou dávkou systémových glukokortikoidov** a s profylaxiou podľa rizika a lokálnych pravidiel.
- ☐ Myslieť na infekčné riziko, gastroprotekciu a ochranu kostí podľa kontextu.
- ☐ Pri voľbe liečby zohľadniť diabetes, latentné infekcie, stav kostí a dostupnosť lieku.

6) Monitorovanie liečby

- ☐ Sledovať **proteinúriu** ako hlavný ukazovateľ účinku.
- ☐ Sledovať **eGFR** a tlak krvi.
- ☐ Pri kortikoidoch sledovať bezpečnostné parametre podľa rizika a zvoleného režimu.
- ☐ Pri nečakanom alebo nevysvetliteľnom priebehu prehodnotiť adherenciu, základnú liečbu a diferenciálnu diagnostiku.

7) Praktická veta do dokumentácie

„Pacient s IgA nefropatiou: diagnóza potvrdená biopsiou. Zavedené základné nefroprotektívne opatrenia a ciele tlaku krvi. Pri riziku progresie zvolená cielenejšia liečba (Nefecon, ak je dostupný; inak znížené systémové steroidy s profylaxiou). Účinok hodnotím najmä podľa trendu proteinúrie a eGFR.“

Zdroj: *KDOQI US Commentary on the KDIGO 2025 Clinical Practice Guideline for IgA Nephropathy and IgA Vasculitis (AJKD, full text). Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=iga-nefropatia-algoritmus-kdigo-2025-kdoqi · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.